

SH.GSR.11.CSS.05			رقم السياسة
الإنعاش القلبي الرئوي			عنوان السياسة
٢	رقم الإصدار	٢٠٢٦/٠٣/٠١	تاريخ إعداد
٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ اعتماد	٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ تفعيل
١١	عدد الصفحات	٢٠٢٩/٠٤/٠١	تاريخ المراجعة
جميع الاقسام بالمستشفى			نطاق التفعيل
اعتماد	مراجعة		إعداد
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه	لجنة الجودة د/ ايمان سامي		مدير الشؤون العلاجية د/ محمد مختار رئيس قسم العناية المركزة د/ محمد عبد الفتاح فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى صيدناوى

السياسة

- تلتزم مستشفى صيدناوي بتوفير خدمات الإنعاش القلبي الرئوي بجميع أقسام المستشفى.
- يلتزم جميع العاملين بالمستشفى بتفعيل نداء code blue لاستدعاء الفريق المسئول للتعامل مع حالات توقف القلب في جميع أنحاء المستشفى
- تلتزم المستشفى بتنسيق دورات تدريبية على الإنعاش القلبي التنفسي لجميع العاملين (الأطباء والتمريض) بالمستشفى بنظام اليوم الواحد كل سنتين ويمنح الحاصلين على الدورة شهادة تفيد ذلك ويختص بمتابعة حصول العاملين على الدورات رئيسهم المباشر، كما يلتزم كل من مدير الشؤون الطبية و مدير الرعاية المركزة ب التدريب المستمر لأعضاء الفرق المتخصصة في عملية الإنعاش القلبي الرئوي
- يلتزم أعضاء فريق الجودة بتدريب العاملين على بنود السياسة
- فريق الكود بلو مدرب على الاستجابة السريعة والفورية عند الاستدعاء ويجب على جميع أفراد الفريق الطبي المتواجد بالغرفة التي بها حالة الطوارئ والتعامل مع الحالة طبقا لسياسة الإنعاش القلبي الرئوي، الفريق فعال ٢٤ ساعة ٧ أيام أسبوعيا، و مهامه كالآتي:
 - الاستجابة للفرور لجميع نداءات الكود
 - إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وفقاً لبروتوكولات دعم الحياة المتقدمة (ACLS) للبالغين أو بروتوكولات دعم الحياة المتقدمة للأطفال (PALS).

الغرض

- وضع معايير لبدء وانتهاء الإنعاش القلبي الرئوي
- وضع آلية متفق عليها للتنسيق بين الفريق الطبي في المستشفى أثناء الكود بلو
- تحديد مسؤوليات وأدوار كل عضو أثناء الإنعاش القلبي الرئوي

- ضمان كفاءة وفاعلية الإنعاش القلبي الرئوي بواسطة فريق متخصص للإنعاش القلبي الرئوي وذلك لضمان التعامل مع حالات السكتات القلبية الرئوية بشكل آمن وفي الوقت المناسب
- لضمان توافر جميع الأدوية والمعدات واللوازم اللازمة لبدء تدابير دعم الحياة المتقدمة وضمان توحيد عربات الطوارئ في جميع أنحاء المستشفى.
- لتسهيل توثيق دقيق وكامل لحالات الكود والإجراءات المتخذة في نموذج خاص في الملف الطبي.

التعريفات

- كود بلو: هو نداء وطلب تقديم مساعدة فورية في حالات التوقف القلبي الرئوي
- الإنعاش القلبي الرئوي: هو إجراء طبي طارئ وضروري في حالات التوقف القلبي والرئوي وذلك لمنع تلف خلايا المخ الدائم والحفاظ على حياة المريض

إجراءات العمل

١. معايير تشخيص السكتة القلبية لدى البالغين :يُشخَّص توقف القلب سريرياً بناءً على ثلاثة مؤشرات رئيسية:
 - انعدام الاستجابة : غياب استجابة المريض للمؤثرات الجسدية والصوتية (على سبيل المثال: عدم الاستجابة عند الترييب على الكتفين والنداء عليه بصوت عالٍ).
 - غياب التنفس الطبيعي :توقف المريض عن التنفس تماماً (انقطاع النفس) أو وجود أنماط تنفس غير طبيعية (مثل اللهاث أو التنفس الاحتضاري).
 - غياب النبض :عدم القدرة على جس النبض المركزي (السباتي عادةً) خلال مدة تتراوح بين ٥ إلى ١٠ ثوانٍ. وفي حال الشك في وجود النبض بعد انقضاء ١٠ ثوانٍ، يجب البدء الإنعاش القلبي الرئوي فوراً.
٢. معايير تشخيص السكتة القلبية والتنفس لدى الرضع والأطفال :تتطابق المؤشرات الرئيسية للتشخيص مع تلك الخاصة بالبالغين، إلا أنها تتضمن معياراً فسيولوجياً إضافياً؛ نظراً لأن توقف القلب في الفئات العمرية الصغيرة

غالباً ما يكون ثانوياً ناتجاً عن فشل تنفسي أو صدمة (نقص التأكسج)، وليس لاضطراب أولي مفاجئ في نظم القلب.

وتشمل هذه المؤشرات:

- **انعدام الاستجابة:** فقدان الوعي التام وغياب أي استجابة للمنبهات الحسية.
- **غياب التنفس الطبيعي:** انعدام التنفس كلياً أو وجود لهاث غير طبيعي.
- **غياب النبض:** عدم اكتشاف أي نبض مركزي خلال ١٠ ثوانٍ. (يُفحص النبض العضدي للرضع دون سن الواحدة، بينما يُفحص النبض السباتي أو الفخذي للأطفال من سن الواحدة وحتى البلوغ).
- **بطء القلب مع ضعف التروية الدموية:** على عكس البالغين، يُعد انخفاض معدل ضربات القلب إلى أقل من ٦٠ نبضة في الدقيقة دافعاً للبدء الفوري بالإنعاش القلبي الرئوي (CPR) حتى مع وجود نبض محسوس، وذلك إذا ترافق مع علامات ضعف تروية الأنسجة (مثل: شحوب الجلد، أو التبقع، أو الازرقاق، أو تغير الحالة الذهنية)، بالرغم من تقديم دعم كافٍ للأكسجين والتهوية.

٣. يشتمل فريق "الكود بلو" على:

- طبيب العناية (قائد الفريق) حاصل على
ACLS ○
BLS ○
- طبيب القسم المسؤول عن المريض
- ممرضة العناية : مدربة على الضغوطات الصدرية و ال CPR ، كما تقوم ب دورها ب تحضير و إعطاء العلاج التي يطلبها قائد الفريق
- ممرضة القسم
- مشرفة تمريض القسم (تفعيل نموذج ال Code Blue و تسجيل الاحداث حسب البند ٧ من إجراءات العمل)
- كما يتواجد أيضا في الحالات الاتية:

○ طبيب أطفال : طبيب أطفال مدرب على PALS لضبط جرعات الدواء حسب وزن الطفل و

إعطاء الجول المناسب في حال استخدام جهاز الصدمات

○ طبيب نساء و توليد: في حال كود بلو المرأة الحامل ، لاتخاذ أي قرارات بما يخص ولادة

الطفل

٤. يتم عمل جدول ب أسماء طبيب الرعاية وتمريض الرعاية المخصصين للفريق على مدار الأسبوع. يتم تجديد

الجدول ب شكل شهري. في حال عدم تواجد احد أعضاء فريق الكود بلو لاي ظرف، يحل محله نظيره من فريق ال

RRT المحدد لنفس اليوم

٥. يتم نداء الفريق الخاص بال الكود بلو عن طريق تفعيل الكود بالسويتش ، الاتصال بقسم الرعاية، الاتصال ب

أعضاء الفريق شخصيا بموجب جدول الفريق المحدد شهريا ، او اخطار طبيب و ممرض الرعاية شخصيا

● للنداء السويتش يستخدم احد الاكواد التالية حسب الحاجة :

○ كود بلو (الكود بلو للبالغين)

○ كود بلو اطفال (أطفال حتى ١٢ سنة)

○ كود بلو نساء (المرأة الحامل)

● يقوم طبيب القسم أو ممرضة القسم بالبدا بعمل الانعاش القلبي الرئوي لحين حضور طبيب العناية

● تقوم ممرضة القسم أو الطبيب بالاتصال بالسويتش لتفعيل الكود بلو حيث تقوم باخباره (اسم القسم-رقم

الطابق -رقم الغرفة -نوع الكود بلو-اسم المبلغ).

● يجب على الممرضة أو الطبيب المعالج أن يذكروا اذا كان مريض أمومة او طفل أثناء الاتصال بالسويتش

للحصول على المساعدة في حالة مريض الأمومة (المرأة الحامل) او الاطفال.

● يقوم التمريض بإحضار عربة الكراش كار الى حجرة المريض (يكون بها نموذج كود بلو).

● يقوم عامل السويتش بتفعيل الكود بالنداء ثلاث مرات وكل مرة تكرر (كود بلو-كود بلو) باللغة العربية ٣٠

ثانية بين كل ندا واخر (حيث يوجد رقم خاص لخط السويتش خاص بالاكواد فقط) ويتم فيها

– ذكر نوع الكود بلو (اطفال –نساء – كبار) في حال البالغين يكون نداء كود بلو فقط

– اسم القسم ورقم الغرفة

– مثال عامل السويتش: عندما يكون الطفل أقل من ١٢ سنة يتم النداء كالاتي: كود بلو

اطفال قسم الأنف والأذن حجرة ٤

• يقوم عامل السويتش بتوثيق مكالمات الكود في سجل به:

○ اسم القسم – التاريخ – الساعة – رقم الحجرة – اسم المبلغ – وتوقيع من عامل السويتش

○ يجب أن تكون استجابة الفريق للنداء في دقيقتين وفي حال تأخر أي عضو من الأعضاء عن

الاستجابة المحددة يتم عمل نموذج أحداث غير متوقعة

• يقوم عامل الاسانسير بالذهاب فورا الى الدور الخامس لأخذ طبيب العناية إلى مكان الحادث في أسرع وقت ممكن

• يتواجد موظف امن خارج منطقة الكود فورا ويتولى المسؤولية تسهيل مهمة فريق الكود بلو وذلك بإبعاد جميع الزوار عن مكان الكود حسب توجيهات مشرفة التمريض، يجب عليه البقاء في مكان الكود حتى يأذن له قائد الفريق بالانصراف

• يقوم طبيب العناية بالحضور وعمل CPR بالتناوب مع طبيب القسم

• يقوم طبيب العناية بإعطاء أوامر للتمريض بإعطاء الأدوية والمحاليل

• تقوم مشرفة القسم بتوثيق ما يحدث في عملية الإنعاش القلبي الرئوي والأدوية المعطاة (يجب إعادة نطق الأدوية قبل الإعطاء) والعلامات الحيوية قبل وبعد في نموذج محضر الكراش (موجود في عربات الكراش كار)

• يقوم طبيب القسم بنقل المريض إلى وحدة العناية المركزة في حال ان الإنعاش القلبي الرئوي تم بنجاح وتم إنعاش المريض بنجاح

• سيحدد قائد الفريق (أخصائي العناية المركزة) وقت التوقف عن إجراء الإنعاش القلبي الرئوي في حالة عدم نجاح الكود و المريض لا يستجيب لجميع الجهود العلاجية و اعلان وفاة المريض.

٦. يجب أن تكون استجابة الفريق للنداء في غضون ٣ دقائق وفي حال تأخر أي عضو من الأعضاء عن الاستجابة

المحددة يتم عمل نموذج أحداث غير متوقعة

٧. يتم توثيق عملية الإنعاش القلبي الرئوي بنموذج Code Blue Report و يشمل التوثيق الاتي

- اسم المريض الرباعي و رقمه الموحد
- القسم الذي حدث به الكود بلو
- تاريخ ووقت بداية و انتهاء الإنعاش القلبي الرئوي
- نظم نبض القلب عند بداية عملية الإنعاش القلبي الرئوي
- تسلسل احداث الإنعاش ويشمل عدد الصدمات الكهربائية المعطاة وجهدها
- الأدوية المعطاة ووقتها وجرعاتها
- العلامات الحيوية للمريض حال وجوده
- النتيجة النهائية

○ عودة النبض (ROSC)

○ توقف تام للقلب رغم جهود الفريق (وفاة المريض)

– مع كتابة الساعة في كلا الحالتين

• ملاحظات الطبيب

• ملاحظات التمريض

○ تلتزم مشرفة التمريض ب استكمال النموذج و اعتماده من قبل طبيب الرعاية

○ يتم عمل نسختين من النموذج، تحفظ احدهما ب ملف المريض و الأخرى في القسم

٨. يتواجد بالأقسام عربات كراش كار جاهزة المخزون ومكتملة باستمرار ويتم عمل مراجعة اكتمال جميع محتوياتها

دوريا باستخدام قائمة التحقق من استكمال المستلزمات والأدوية

• تكون العربة مجهزة بكامل الادوية و المستلزمات اللازمة لمحاولة انقاذ حياة المريض، تكون الادوية و

المستلزمات المناسبة لجميع الاعمار متواجدة

- يتواجد جهاز صدمات مع كل عربة كراش، كما يتوفر منظار حنجري
- تقوم المشرفة المسؤولة في كل قسم بمراجعة محتويات السطح ومحتويات الكراش والتأكد من أن جميع الاجهزة والمعدات الموجودة على عربة الطوارئ تعمل بكفاءة في بداية كل شفت
- يقوم الصيدلي المسؤول بالمرور على عربة الطوارئ والتأكد من محتوياتها وصلاحياتها مرة شهريا على الأقل
- يتم استعاضة الأدوية المستخدمة من عربة الطوارئ فور الانتهاء من الإنعاش القلبي الرئوي من صيدلية المستشفى
- تسجيل المشرفة المسؤولة نتائج المراجعة في نموذج استلام وتسليم عربة الطوارئ
- يتم قفل الكراش ب قفل مرقم ترقيم مسلسل و يسجل رقم القفل المكسور و القفل الذي تم تركيبه، مع كتابة ما تم استخدامه من العربة بنموذج محضر فتح عربة الكراش
- لا يتم قفل الكراش الا بعد استعاضة و استكمال الكراش
- ٩. يرافق طبيب الرعاية المريض في سيارة الإسعاف في حالة نقله الى مستشفى اخر
- ١٠. تقوم مشرفة التمريض ب تسجيل وقت بداية الإنعاش القلبي الرئوي و وقت وصول الفريق ب خانة ملاحظات التمريض ب نموذج الكود بلو
- ١١. في حال حدوث حدث غير متوقع يكتب على نموذج الأحداث غير المتوقعة وإعطائه لمكتب الجودة
- ١٢. يتم تفعيل نداء بالكود بلو لإدارة الإنعاش القلبي الرئوي في جميع انحاء المستشفى باستثناء الرعاية الحرجة وحجرات العمليات، يتم التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي من قبل الأطباء المتواجدين المدربين في الرعاية او العمليات (أطباء التخدير) و لا يعلن عن الكود بلو
- ١٣. يتواجد أخصائي عناية المبتسرين (قائد الفريق) مع طبيب المقيم طبيب القسم و مشرفة القسم وتمريض القسم (أعضاء الفريق) للتعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي داخل رعاية المبتسرين دون الإعلان عن كود بلو
- ١٤. مهام لجنة الإنعاش القلبي الرئوي

- التأكد أن جميع أعضاء الطاقم الطبي مؤهلون ومدربون على الانعاش القلبي الرئوي وعلى دراية بسياسة

المستشفى

- تحسين عملية الاستجابة للكود وكذلك تحسين إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي لكل من الكبار والأطفال
- تضع وتراجع وتعتمد سياسات وإجراءات الانعاش القلبي والرئوي والتي توجه لكيفية العناية بحالات التوقف

القلبي

- تراجع وتقيم جميع تقارير الانعاش القلبي الرئوي
- تراقب وتطور مؤشرات لتقييم عمليات ونتائج الكود بلو
- تنظم برنامج إجباري على الانعاش القلبي

المسؤول عن التنفيذ

١. الاطباء
٢. التمريض
٣. عمال المصاعد
٤. مسؤول السويتش
٥. موظف الامن

المراقبة والتقييم

- يتم اختبار نظام الاستدعاء بشكل مفاجئ من قبل مدير القسم/ منسق الجودة بالمستشفى للتأكد من استجابة الأطباء والتمريض للنداء وحساب الوقت بين الاستدعاء والاستجابة كنوع من تقييم الأداء داخل القسم مع رفع النتائج إلى مدير المستشفى

- KPI : يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته

النتيجة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر

- تقوم المستشفى بمتابعة وجمع وتحليل والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بعملية الإنعاش القلبي الرئوي
- تعمل المستشفى على فرص التحسين المحددة في عملية تقييم الإنعاش القلبي الرئوي

النماذج / المرفقات

- نموذج الكود بلو

معايير ذات صلة

ICD.22 Recognition and response to clinical deterioration; CCS.01 Critical care; MMS.05 Emergency Medications

المراجع

- دليل معايير اعتماد المستشفيات - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ، إصدار ٢٠٢٥ . معيار

CCS.05

[illegible]



الهيئة العامة للتأمين الصحي

فرع:

مستشفى:

Nursing Supervisor Notes:

.....

.....

.....

.....

Team Leader Report:

.....

.....

.....

.....

Return of spontaneous circulation (ROSC): Yes: ☐ Transferred to:..... at (Time):.....

No: ☐ Time of death:

Team Members	Names	Signature
Team Leader		
Primary Physician		
Nursing Supervisor		
Assigned Nurse		

MR . Code . Blue 2-2